

Physiologie du Corps Vitre

Resume structure – Dr Saadouli D

I. Introduction

Le **corps vitre** est un tissu conjonctif specialise, gel visqueux transparent, support des tissus intra-oculaires.

- Constitue les **4/5 du volume oculaire**.
- Situe en arriere du cristallin.
- Intervient dans le maintien de la **pression intraoculaire**.
- Proprietes : **transparent, avasculaire, quasiment acellulaire**.
- Richesse en eau : **99 %**.

II. Composition

Eau	99 % du volume
Collagene	Fibres orientees arbitrairement ; structure en gel
Acide hyaluronique	Phase liquide ; produit par les hyalocytes
Hyalocytes	Cellules les plus nombreuses ; synthese acide hyaluronique + phagocytose
Fibroblastes	Cellules du vitre (moins nombreux)
Localisation cellulaire	Concentrees au niveau du cortex vitreen

III. Anatomie

A. Structures Nommees

Ligament hyaloidocapsulaire (Weiger)	Zone annulaire de fixation du vitre sur la face posterieure du cristallin
Espace d'Erggelet / Berger	Centre du ligament hyaloidocapsulaire
Canal de Cloquet	Nait de l'espace de Berger → chemine vers l'arriere ; ancien site de l'artere hyaloidienne
Aire de Martegiani	Zone en entonnoir en avant de la papille optique ; debouche du canal de Cloquet

B. 3 Parties du Vitre

1. Les Zones	Zone preretiniene (dense, cortex vitreen post.) / Zone intermediaire (semi-liquide) / Zone retrolentale (cote cristallin)
2. Les Tractus	Systeme de membranules a grande resistance mecanique dans le vitre central semi-liquide

3. Les Lacunes

Regions de basse densite

C. Membrane Hyaloide Anterieure

- Recouvre la partie anterieure du corps vitre.
- Se termine au milieu de la pars plana (ligne blanche anterieure = limite de la base du vitre).

D. Rapports du Vitre

- **Anterieurs** : cristallin, zonule.
- **Posterieurs** : retine – fortes adherences au niveau de la **base du vitre**, peri-papillaire et peri-maculaire.

IV. Corps Flottants (Myodesopsies)

Corps pathologiques flottant dans le vitre → impression de **mouches volantes**.

V. Evolution avec l'Age

Le vitre subit une **degenérescence progressive** :

- Liquefaction progressive → formation et confluence de lacunes
- → **Decollement posterieur du vitre (DPV)**
- → Tractions sur la retine → risque de pathologies

VI. Pathologies du Corps Vitre

Decollement posterieur du vitre	Complication frequente liee a l'age ; myodesopsies, phosphenes
Dechirure retinienne	Liee aux tractions vitreennes sur la retine peripherique
Decollement de retine	Urgence ! Secondaire a une dechirure retinienne
Hemorragie vitreenne	Baisse AV, voile sombre ; associee au diabete
Proliferation vitreoretinienne	Membranes pathologiques a l'interface vitreoretinienne
Trou maculaire	Lie aux tractions vitreennes peri-maculaires

POINTS CLES A RETENIR

- Vitre = 4/5 du volume oculaire ; gel transparent, acellulaire, avasculaire.
- Composition : 99 % eau + fibres de collagene + acide hyaluronique + hyalocytes.
- Hyalocytes : synthese acide hyaluronique + phagocytose.
- Adherences fortes : base du vitre, peri-papillaire, peri-maculaire.
- Avec l'age : liquefaction → DPV → tractions → risque dechirure / decollement retinien.
- Diabete → alteration du vitre → hemorragie vitreenne.